MASOTERAPIA I

Semana 14

DRENAJE LINFATICO - PRACTICA

Docente

Lic. Gilmer Emilio Malca C.

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Qué es el drenaje linfático ?

Presente.

- **VIDEO DEMOSTRATIVO: Observar el video.**

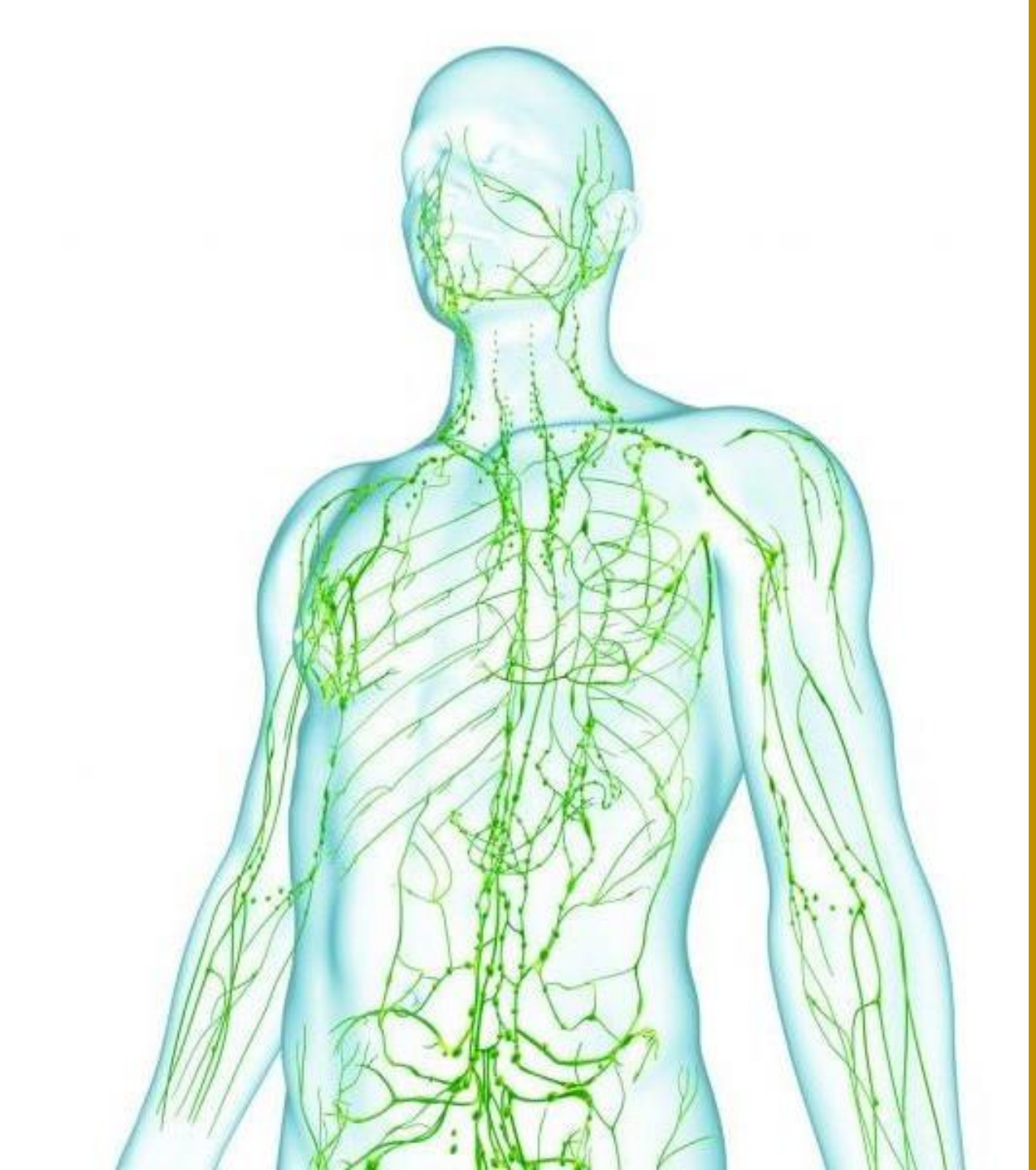
- https://www.youtube.com/watch?v=Fd80-ooOkI8

- **OBSERVE LA IMAGEN:**

- **LOGRO:**

- **Que alumno identifique los conceptos principales acerca del drenaje linfático así como las principales técnicas.**

DRENAJE LINFÁTICO



¿Qué es el sitema linfatico?

- Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguineo.
- El sistema linfático comprende las amigdalas, las adenoides, el bazo y el timo.

LINFA: Líquido entre transparente y blanquecino compuesto de:

- Glóbulos blancos(linfocitos)
- Liquido proveniente los intestinos llamado quilo que contiene proteínas y grasas.

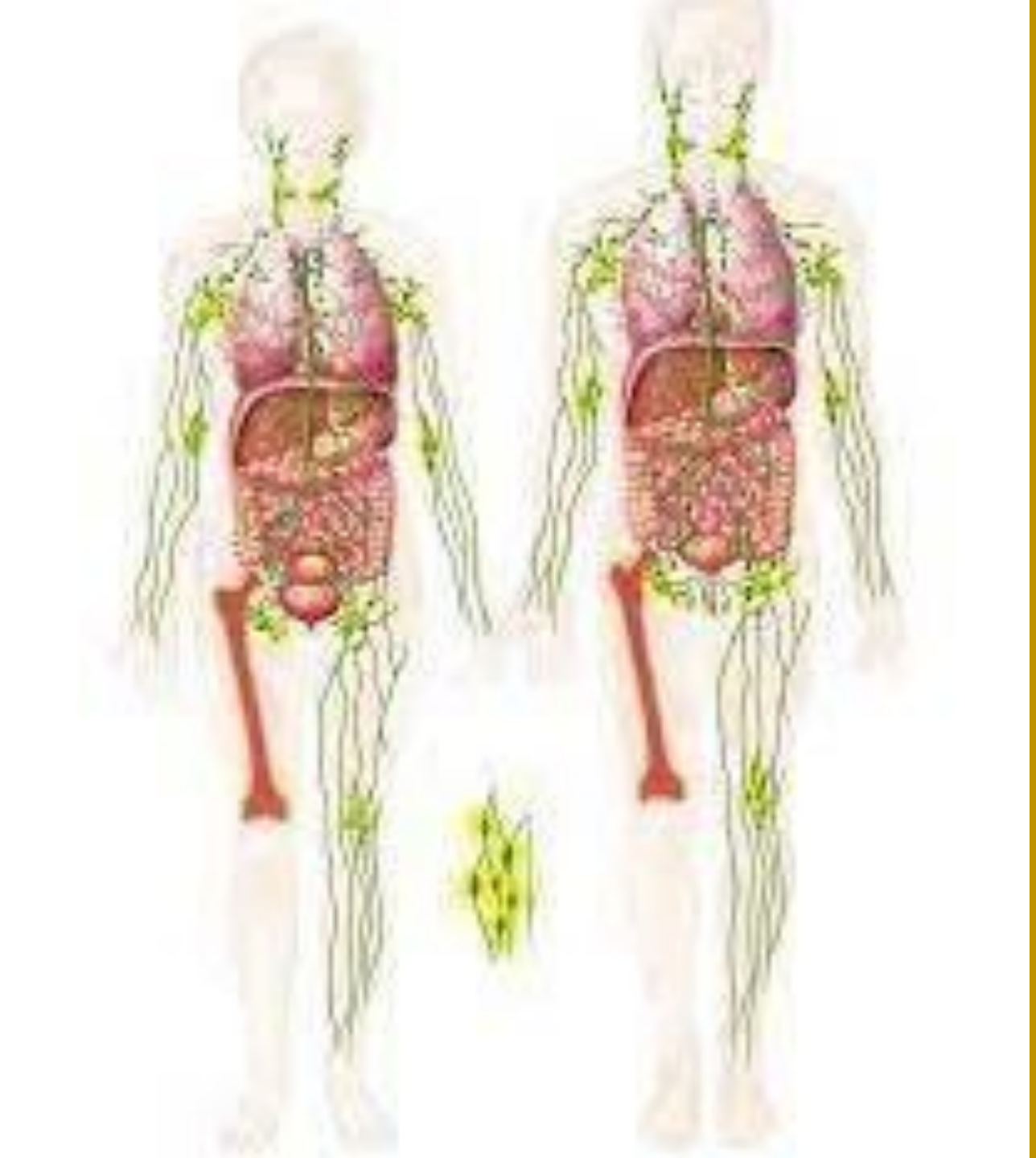
DLM

- Método destinado a mejorar las funciones esenciales del sistema linfático por medio de maniobras precisas, proporcionadas y rítmicas, que actúan activando y mejorando la circulación linfática y favoreciendo la eliminación de sustancias de desecho.

- Las maniobras para realizar un DLM, deben ser suaves y muy delicadas, pues si son bruscas, en lugar de favorecer que el exceso de linfa sea drenad, se lesionan los vasos de la red linfática subdérmica, conduciendo a un agravamiento del linfedema.

CARACTERISTICAS DEL DLM

- Efectos terapéuticos en el sistema parasimpático
- No se realiza fricción
- No produce hiperemia ni hipertermia
- No se realiza fuerza
- Flexibilidad de la muñecas
- Empuje tangencial de la piel
- No produce dolor, es relajante
- El ritmo es lento
- No se utilizan productos
- Trabajar siempre de proximal a distal.

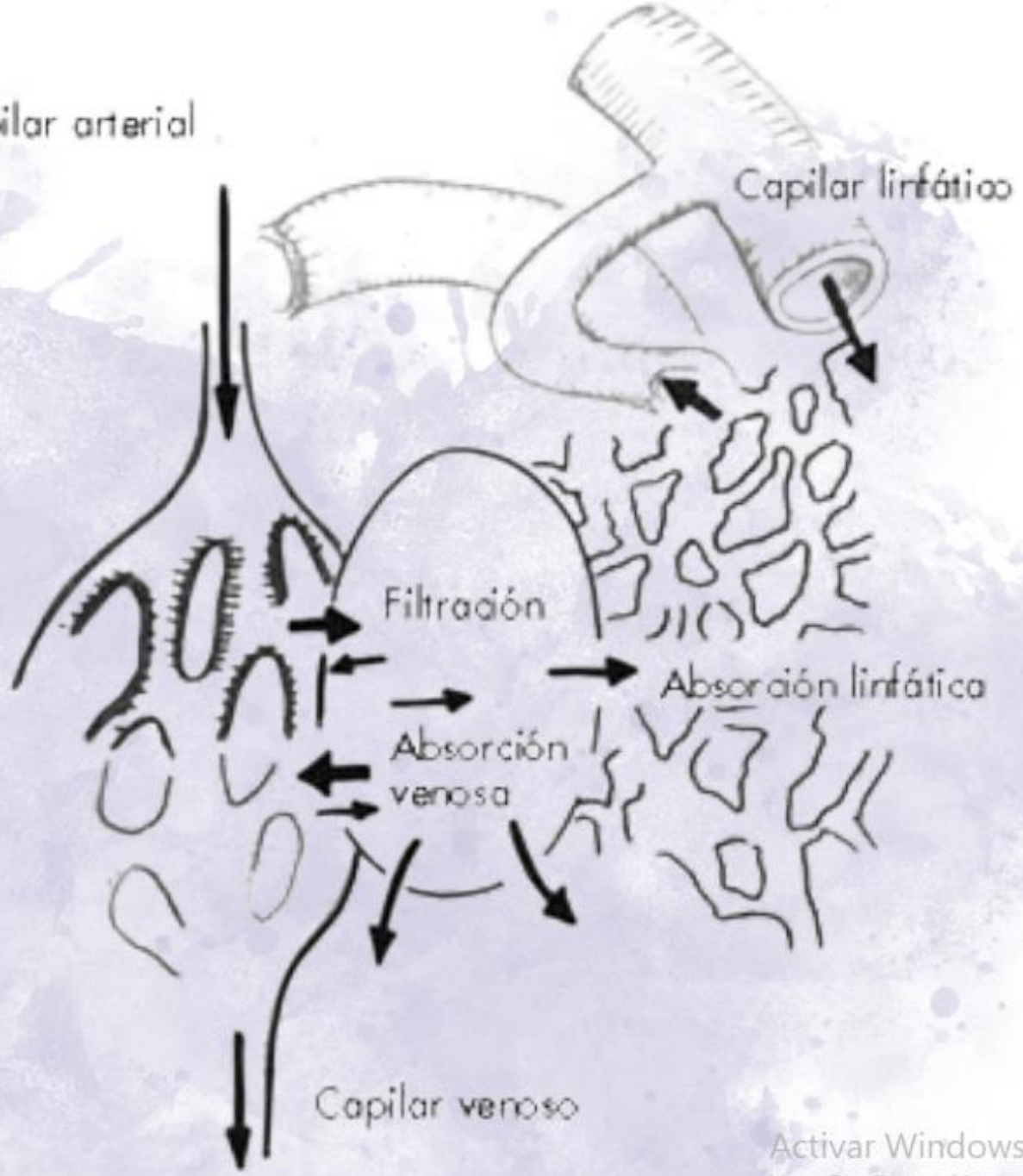


- Ritmo
  - Repeticiones lentas y rítmicas estimulan la ola en el fluido linfático similar a los movimientos peristálticos.
- Duración
  - Cuerpo completo: 45 mins.
  - Áreas localizadas: 5-15 mins.
- Arrastre
  - Abre los extremos proximales de los capilares, permitiendo que entre el fluido intersticial de los tejidos

Principios del DLM

Drenaje linfatico manual.

Activar Windows



Activar Windows
Ve a Configuración para ac

Emil y Estrid Vodder

Emil y Estrid Vodder

A principio de los años 30 el matrimonio danés Emil y Estrid Vodder trabajan como fisioterapeutas en Cannes, en la Costa Azul Francesa. Gran parte de sus pacientes procedían de la húmeda y fría Inglaterra.

La mayoría venían aquejados de enfermedades infecciosas crónicas de las vías respiratorias superiores (sinusitis, faringitis, amigdalitis, etc.), atraídos por el clima soleado del Mediterráneo. Lo que más sorprendía a Vodder era que a prácticamente todos ellos se les palpaban unos ganglios linfáticos del cuello hinchados y duros.

Emil y Estrid Vodder

Intuitivamente se le ocurrió que un suave masaje a estos ganglios mejoraría el estado de salud de aquellos pacientes crónicos, lo cual se confirmó ampliamente en la práctica. El Dr. Vodder (1896-1986) a pesar de no ser médico, ya que aunque había hecho algunos cursos de medicina en realidad era doctor en filosofía, hizo un descubrimiento genial que ha constituido un gran avance dentro del campo de la medicina y de la estética.

Según él, la idea inicial del drenaje linfático se le ocurrió en sueños.

Lo cierto es que atreverse a masajear ganglios cuando la medicina oficial de la época recomendaba no tocarlos merece cuanto menos la admiración de todos nosotros.

CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

- Ejecucion en un lugar especial y especifico
- Luz indirecta
- Temperatura agradable
- Los pies deben estar ligeramente elevados
- Limpieza
- Toallas y sabanas limpias
- Respiracion lenta y profunda
- Manos del terapeuta no deben estar frias.
- El ritmo será lento de 10-12 maniobras
- Movimientos ligeramente circulares, tangencionales y centripetos

Activar Windows
Ve a Configuración para ac

- Las maniobras **NUNCA** deben ocacionar dolor
- La intensidad y las maniobras dependeran de la afeccion presente.

Al final del tiempo de relajación, el sujeto doblará las rodillas, los pies estarán colocados en la mesa de modo que los músculos rectos del abdomen se relajen y el sujeto pueda respirar profundamente. Todo este proceso favorecerá especialmente el retorno linfático por el trabajo hidráulico que realiza el músculo diafragma y secundariamente mejorará el retorno venoso.

GENERALIDADES SOBRE LAS MANIPULACIONES

Antes de iniciar con las particularidades de las manipulaciones, es importante que se conozcan cierta caracteristicas de las mismas.

- Las manipulaciones deben ser suaves caricias tangencionales
- Empujes son tangencionales
- Sin friccion, sin resbalar, en direccion y sentido del desagüe
- Adapatar al maximo nuestros dedos y manos a la superficie que estamos trabajando
- Las presiones tangencionales de empuje, deben seguir un movimeinto eliptico, circular o en espiral, segun el area de trabajo.
- El DLM se trabaja de proximal a distal.
- Las manipulaciones del DLM suelen ser de uno 30-40 Torr

MANIOBRAS DE DRENAJE LINFATICO:

Básicamente todas las manipulaciones de DLM constan de tres fases:

1. Apoyo (de manos y dedos)
2. Empuje (con las manos y/ o dedos)
3. Relajación (dejando de presionar; la piel vuelve por sí sola a la posición inicial)

La práctica del DLM se basa cuatro manipulaciones fundamentales, algunas variantes y combinaciones, cuya finalidad primordial es adaptarse a la superficie cutánea y poder drenar lo mejor posible las distintas partes morfológicas del cuerpo humano. Sus nombres fueron creados en su día por el Dr. Vooder tratando de definirlas lo mejor posible.

Activar Windows

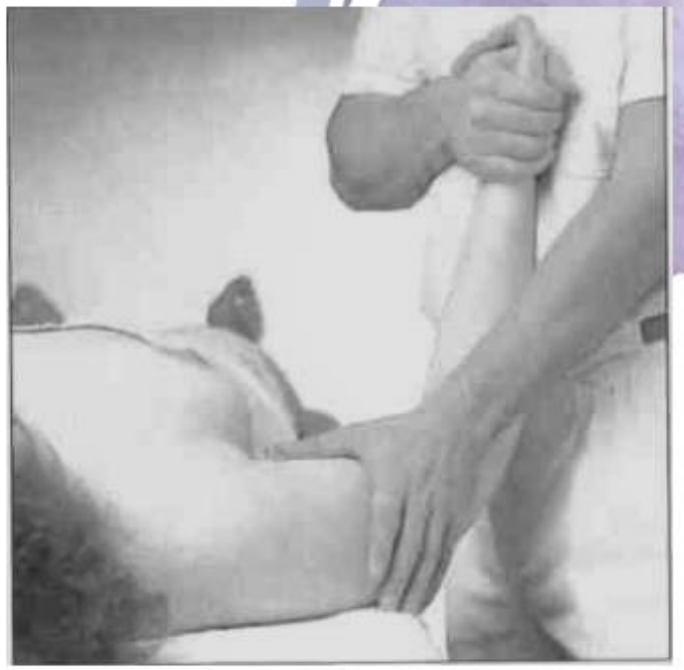
Circulos fijos CF

Las manos y los dedos permanecen pasivos, siendo las muñecas la parte realmente móvil (en ésta y en todas las manipulaciones de DLM) Su lugar primordial de aplicación son la cara, cabeza, nuca, cuello, zonas ganglionares superficiales (axilas, ingles), codos, rodillas, manos y pies. En cada una de éstas partes del cuerpo utilizaremos unas variantes u otras, eligiendo la más apropiada en cada caso.

Activar Windows
Ve a Configuración para ac

MANIPULACIÓN DE BOMBEO, B:

Su lugar de aplicación más apropiado son las partes curvas y alargadas del cuerpo, como son las extremidades (brazos, muslos, piernas) y las partes laterales del tronco (<flancos>) Nuestras manos van a rodear en lo posible la parte curva a tratar, fundamentalmente entre los dedos pulgar e índice. Hay que evitar sobre todo ejercer una presión de tipo <cortante>, por ello antes de empujar hay que adaptar cada bien cada vez la palma de la mano (fase de apoyo) y levantar un poco la línea anterior de contacto durante la fase de empuje para no <clavarla>.



MANIPULACIÓNCOMBINADA, B – CF:

En realidad no se trata de una manipulación con características propias, sino que resulta de la combinación sucesiva de un bombeo B realizado con la mano que va por detrás, con un circulo fijo CF con la mano que va por delante.
Sus lugares de aplicación son los mismos que los citados en el apartado de los bombeos. En la práctica se utiliza mucho más que éstos, ya que técnicamente resulta una manipulación más cómoda de realizar, a la vez que permite una mayor accesibilidad a la superficie corporal que los bombeos realizados a dos manos.

Activar Windows

MOVIMIENTO DADOR, D:

Es una variante de los bombeos B que tiene su lugar de aplicación exclusivamente en las partes distales de las extremidades (antebrazos y piernas) Se diferencia fundamentalmente de ellos en que tiene un cuarto movimiento, consiste en un movimiento lateral de los dedos hacia fuera (de la línea media de la extremidad) y cuyo centro de giro es la articulación inicial (metacarpo-falangica) del dedo índice. En ésta manipulación la palma de la mano mira siempre hacia el terapeuta. El desplazamiento de la mano y los dedos da la sensación de movimiento en espiral o en <sacacorchos>. Los dadores D pueden realizarse con una sola mano o con las dos de forma alternativa.

Activar Windows
Ve a Configuración para ac

MOVILZACION GIRATORIA, GIROS; G

Se trata de la manipulación más apropiada para tratar las grandes superficies planas del cuerpo, como son las partes anterior y posterior de tronco (pecho, vientre, espalda y zona glúteo-lumbar) Para realizar los giros G vamos apoyando nuestras manos sobre la piel del paciente con los pulgares abiertos (separados) y el resto de los dedos estirados pero no tensos.

Tus talentos y habilidadee iran mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar

(Martin Luther King)

Activar Windows

- **Actividad para la clase**

- Realizar un resumen en grupo de los diferentes conceptos, características y técnicas manuales dentro del drenaje linfático.

- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿Qué dificultades tuvimos?
- ¿Para que nos sirve lo aprendido?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

•CONSULTAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Vodder, Emil & Estrid Vodder."Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage: A Practical Guide."Thieme, 2006.→ Una de las fuentes más importantes, creada por los fundadores de esta técnica.
- Enfoque práctico y terapéutico.Földi, M., Földi, E."Textbook of Lymphology: For Physicians and Lymphedema Therapists."Elsevier, 2012.→ Texto completo sobre el sistema linfático y sus patologías, con énfasis en el drenaje linfático manual.Leduc, Albert & Guy Leduc.
- "Manual Lymph Drainage."Thieme, 2010.→ Describe el método Leduc, una de las técnicas más utilizadas en fisioterapia y rehabilitación.
- Wittlinger, Hildegard & Wittlinger, Andreas."Dr. Vodder’s Manual Lymph Drainage: Basic and Therapy 1."Wittlinger Therapy Center, 2010.→ Manual oficial de formación en la técnica Vodder, utilizado en centros de entrenamiento.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

GRACIAS

Presente.